



- 1/ Ce questionnaire comprend 50 Questions à choix unique ou multiple, avec 4 figures, s'il est incomplet appelez un surveillant.
2/ Pour les QCM /QCU, la ou les réponses doivent être cochées

Dermatologie

- 1- Un Patient de 50 ans, hypertendu sous inhibiteur calcique, tabagique chronique présente des lésions érythémato-squameuses au niveau des coudes et des genoux évoluant par poussées et rémission depuis 10 ans. La conduite à tenir consiste :
- A- Arrêter le traitement par l'inhibiteur calcique et le remplacer par un autre antihypertenseur
 - B- Conseiller l'arrêt du tabagisme
 - C- Faire la biopsie cutanée pour confirmer le diagnostic
 - D- Traiter par des dermocorticoïdes
 - E- Traiter par une corticothérapie par voie orale
- 2- Un patient de 65 ans présente une lésion nodulaire translucide télangiectasique de 2 cm de diamètre au niveau du front augmentant progressivement de taille depuis 3 ans. Le diagnostic le plus probable est :
- A- Carcinome baso-cellulaire
 - B- Carcinome épidermoïde
 - C- Mélanome achromique
 - D- Maladie de Paget extra mammaire
 - E- Maladie de Bowen
- 3- Le mélanome
- A- Survient le plus souvent sur un nevus préexistant
 - B- Est une tumeur à malignité locale
 - C- Siège le plus souvent au Maroc au niveau de la plante du pied
 - D- La prévention consiste à enlever tous les nevus de façon systématique
 - E- Peut atteindre les ongles
- 4- Un patient de 50 ans, agriculteur, de phototype clair présente des taches rugueuses brunâtres au nombre de 4 sur les joues et le front de 0,5 cm de diamètre. Le diagnostic le plus probable est :
- A- Les cornes cutanées
 - B- Les leucoplasies
 - C- Les kératoses actiniques
 - D- Le psoriasis en goutte
 - E- Maladie de Bowen
- 5- Le carcinome épidermoïde
- A- Respecte les muqueuses
 - B- Survient le plus souvent sur une lésion précancéreuse
 - C- Ne donne pas de métastase systémique
 - D- A un aspect le plus souvent ulcéreux ou ulcéro-végétant
 - E- Se traite essentiellement par l'association de chirurgie et de chimiothérapie
- 6- Une jeune fille de 15 ans présente un aspect luisant et des microkystes blanc et des comédons. Quelles sont les propositions exactes ? :
- A- Cette patiente présente une acné mixte
 - B- Le traitement consiste à prescrire les cyclines et adapalène
 - C- Le traitement consiste à prescrire une antibiothérapie locale pendant 6 semaine
 - D- Le traitement consiste à prescrire l'Adapalène seule
 - E- Le traitement consiste à prescrire l'Isotrétinoïne per os

- 7- Concernant le pemphigus vulgaire, quelle(s) proposition(s) est/sont correcte(s) ?
- A- Il s'agit d'une dermatose bulleuse auto-immune sous-épidermique
 - B- Les bulles sont flasques
 - C- L'atteinte des muqueuses est fréquente
 - D- Le signe de Nikolsky est positif
 - E- Les auto-anticorps sont dirigés contre le collagène VII
- 8- Une femme de 78 ans présente un prurit intense évoluant depuis plusieurs mois, avec apparition secondaire de bulles tendues sur peau érythémateuse depuis deux mois. Le signe de Nikolsky est négatif. Quel diagnostic évoquez-vous en premier ?
- A- Erythème pigmenté fixe bulleux
 - B- Lupus cutané bulleux
 - C- Pemphigoïde bulleuse
 - D- Pemphigus vulgaire
 - E- Urticaire bulleuse
- 9- Quel examen permet de confirmer ce diagnostic ?
- A- Anticorps antinucléaires
 - B- Cytodiagnostic de Tzanck
 - C- Dosage des IgE totaux
 - D- Étude histopathologique d'une bulle couplée à une immunofluorescence directe sur biopsie cutanée péri-lésionnelle
 - E- Patch tests
- 10- Parmi les propositions suivantes, quelle description sémiologique est la plus évocatrice d'un érythème noueux ?
- A- Bulles tendues sur peau érythémateuse avec signe de Nikolsky positif
 - B- Nodules indolores, ulcérés, à évolution chronique
 - C- Noueures douloureuses, bilatérales, siégeant sur la face antérieure des jambes, sans ulcération ni nécrose
 - D- Papules purpuriques nécrotiques des membres inférieurs
 - E- Plaques infiltrées anesthésiques à limites nettes
- 11- Un homme de 24 ans consultait pour un prurit généralisé, évoluant depuis 7 mois. L'examen dermatologique ne trouvait aucune lésion élémentaire, en dehors de lésions de grattage diffuses. À l'interrogatoire, le patient rapportait une asthénie, et une perte de poids. Quelle étiologie est la plus probable devant ce tableau ?
- A- Gale
 - B- Gommages tuberculeuses
 - C- Lymphome de Hodgkin
 - D- Psoriasis
 - E- Urticaire chronique
- 12- Concernant la tuberculose cutanée, quelles propositions sont correctes ?
- A- La tuberculose cutanée est toujours secondaire à une atteinte pulmonaire active
 - B- L'évolution est le plus souvent chronique et lente
 - C- Certaines formes peuvent évoluer vers des lésions mutilantes ou cicatricielles
 - D- La guérison spontanée est fréquente sans traitement
 - E- L'immunosuppression favorise les formes étendues ou disséminées
- 13- Concernant les manifestations cutanées du VIH :
- A- Elles peuvent survenir à tous les stades
 - B- Elles sont toujours tardives
 - C- Elles peuvent être révélatrices de l'infection
 - D- Elles sont toujours infectieuses
 - E- Elles ont une valeur pronostique

14- Le chancre syphilitique dans sa forme typique est :

- A- Indolore
- B- Induré
- C- Sale et purulent
- D- Unique
- E- Très prurigineux

15- Les germes fréquemment en cause des urétrites sont :

- A- *Neisseria gonorrhoeae*
- B- *Chlamydia trachomatis*
- C- *Trichomonas vaginalis*
- D- *Treponema pallidum*
- E- *Candida albicans*

16- L'urticaire superficielle est caractérisée par :

- A- Des papules œdémateuses fugaces
- B- Une durée des lésions > 48 h
- C- Un prurit fréquent
- D- Une cicatrice résiduelle
- E- Un œdème dermique

17- Ces formes font partie des toxidermies graves :

- A- Nécrolyse épidermique toxique
- B- Syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse (DRESS)
- C- Pustulose exanthématique aiguë généralisée
- D- Érythème polymorphe mineur
- E- Photosensibilité

18- Toute ulcération génitale aiguë est :

- A- Une infection sexuellement transmissible jusqu'à preuve du contraire
- B- Le plus souvent virale
- C- Toujours syphilitique
- D- Une urgence diagnostique
- E- Bénigne

19- Brahim âgé de 55 ans, diabétique, était admis aux urgences à 4 heures du matin pour cette lésion du dos apparue depuis 3 jours (Figure 1), dans un contexte de fébrile et altération de l'état général. Vous évoquez en premier :

- A- Un kyste épidermoïde surinfecté
- B- Une gomme tuberculeuse
- C- Un furoncle
- D- Un anthrax
- E- Une gomme syphilitique

20- Yasser, enfant âgé de 5 ans, il présentait depuis une semaine ces lésions (Figure 2). Vous expliquez à la maman que c'est :

- A- Une dermatite atopique
- B- Un impétigo
- C- Un eczéma de contact
- D- Un psoriasis
- E- Une Staphylococcie de la face

21- Mr Ahmed, âgé de 60 ans, diabétique sous metformine, consulte pour cette lésion axillaire apparue depuis deux semaines (Figure 3). Quel est votre diagnostic :

- A- Candidose du pli axillaire
- B- Erythrasma du pli axillaire
- C- Eczéma de contact du pli axillaire
- D- Psoriasis du pli axillaire
- E- Dermatophytie du pli axillaire

22- Un nourrisson Omar âgé de 17 mois consulte pour des lésions évoquant une dermatite atopique. Vous expliquez aux parents :

- A- L'usage d'un nettoyant surgras et des émollients, est obligatoire
- B- L'usage des antiseptiques de façon quotidienne est obligatoire
- C- L'usage des dermocorticoïdes est interdit chez le nourrisson
- D- La vaccination est contre-indiquée chez les enfants atopiques
- E- L'usage des antibiotiques topiques est contre indiqué chez les enfants atopiques

23- La teigne microsporique

- A- Est due à un dermatophyte zoophile
- B- Peut se localiser en dehors du cuir chevelu
- C- Peut se manifester par une grande plaque alopécique du scalp
- D- Est traitée par griséofulvine 20 mg/kg/j pendant 8 semaines
- E- Est traitée par fluconazole 15 mg/kg/j pdt 15 jours

24- Mme Rachida, âgée de 30 ans, vous consulte pour des lésions évoluant depuis 07 jours avec prurit intense (Figure 4). Quel est votre diagnostic :

- A- Eczéma de contact des pieds
- B- Impétigo des pieds
- C- Zona des pieds
- D- Dermatophytie des pieds
- E- Candidose cutanée des pieds

25- Mamoun, enfant âgé de 5 ans, il présentait depuis une semaine des lésions prurigineuses vésiculeuses évoquant une varicelle. Vous expliquez à la maman que c'est une infection :

- A- Contagieuse
- B- Due au HPV
- C- Bénigne chez l'enfant
- D- Sévère chez l'adulte
- E- Qui se complique de syndrome de Rye

- 26- Mr Rachid, 53 ans est hospitalisé en neurochirurgie pour AVC ischémique, l'interrogatoire retrouve une HTA négligée évoluant depuis l'âge de 26 ans, qui d'après la famille n'a jamais été équilibrée. Quels sont les éléments vous faisant suspecter une HTA secondaire ?
- A- Le sexe masculin
 - B- L'âge jeune de survenue de l'HTA
 - C- L'existence de céphalées
 - D- L'HTA chez son cousin
 - E- La résistance thérapeutique à une quadrithérapie
- 27- L'examen clinique de Mr Rachid révèle des vergetures pourpres, larges faisant évoquer un syndrome de Cushing, quelles autres manifestations cliniques sont observées en cas d'hypercorticisme ?
- A- Une obésité facio-tronculaire
 - B- Des tremblements
 - C- Un myxoedème
 - D- Une fièvre chronique
 - E- Des membres grêles
- 28- Quels sont les examens biologiques de confirmation de l'hypercorticisme ?
- A- L'ACTH
 - B- Le cortisol plasmatique à minuit
 - C- Le cortisol libre urinaire
 - D- Le test au synacthène
 - E- Le freinage minute à la Dexaméthasone
- 29- Une fois l'hypercorticisme confirmé, quelle exploration nous permettra d'orienter le diagnostic étiologique (une seule réponse) ?
- A- Le dosage de l'ACTH plasmatique
 - B- L'IRM hypophysaire
 - C- L'octréoscaner
 - D- Le scanner surrénalien
 - E- Le freinage minute à la Dexaméthasone
- 30- Quelles sont les réponses justes concernant la maladie de Cushing ?
- A- Est liée à un adénome corticotrope
 - B- Relève d'une chirurgie transsphénoïdale
 - C- Relève d'une chirurgie par voie transcrânienne
 - D- Est en rapport avec un adénome cortisolique
 - E- L'ACTH dans ce cas est normal à élevé
- 31- Quelles sont les causes possibles d'un syndrome de Cushing ACTH indépendant ?
- A- Un adénome cortisolique
 - B- Un adénome corticotrope
 - C- Un corticosurrénalome
 - D- Une hyperplasie nodulaire des surrénales
 - E- Une tumeur neuroendocrine pulmonaire

32- Asmaa, 36 ans consulte pour un retard de règles de 3 mois avec à l'examen une galactorrhée provoquée bilatérale, une hyperprolactinémie est confirmée biologiquement, elle peut être associée à :

- A- Une prise d'antidépresseurs
- B- Une prise de paracétamol
- C- Une hyperthyroïdie
- D- Une insuffisance rénale méconnue
- E- Une insuffisance cardiaque

33- La prolactinémie est à 500ng/ml et l'IRM met en évidence un adénome de 32x 10 mm, il s'agit probablement d'un :

- A- Macroadénome somatotrope
- B- Un macroprolactinome
- C- Un macroadénome non fonctionnel
- D- Un macroadénome corticotrope
- E- Un microadénome à prolactine

34- Le traitement de première intention dans ce cas repose sur :

- A- Des agonistes dopaminergiques
- B- Une radiothérapie
- C- Des analogues de la somatostatine
- D- La chirurgie de l'adénome
- E- Une abstention avec surveillance

35- La patiente présente suite à l'expertise ophtalmologique une diplopie et un strabisme, ceci est en faveur :

- A- D'une extension latérosellaire
- B- D'un développement postérieur de l'adénome
- C- D'un envahissement du chiasma optique
- D- D'une atteinte du sinus caverneux
- E- D'une atteinte des sinus pétreux

36- Les céphalées rétro-orbitaires intenses en cas d'adénome hypophysaire sont le témoin :

- A- D'une augmentation de la pression au niveau de la loge hypophysaire
- B- D'une extension latérosellaire
- C- D'une extension vers le diaphragme sella et irritation de la dure mère
- D- De la malignité de la tumeur
- E- D'une extension vers la fosse cérébrale postérieure

37- Dans le cadre des nodules thyroïdiens :

- A- L'utilisation du score EU-TIRADS est impérative
- B- Les nodules classés EU-TIRADS 4 ont un risque très élevé de malignité
- C- La cytoponction échoguidée à l'aiguille fine est recommandée pour tout nodule classé EU-TIRADS 5 de plus de 5 mm de grand axe
- D- La chirurgie est indiquée devant tout nodule mesurant plus de 4 cm de grand axe, quel que soit le score EU-TIRADS et quel que soit le bilan thyroïdien
- E- Le dosage de la thyroglobuline est systématique avant toute chirurgie

38- Devant une thyrotoxicose typique, on demande :

- A- La LT4 et les Ac anti-récepteurs de la TSH en premier
- B- La LT3 et les Ac anti-thyroglobulines en premier
- C- La TSH, la LT4 et LT3 en premier
- D- Le couple TSH/LT4 en premier
- E- Le couple TSH/LT3 en premier

39- Dans le cadre des hyperthyroïdies périphériques :

- A- La maladie de Basedow est plus fréquente chez les femmes
- B- Le diagnostic positif de la maladie de Basedow repose sur le dosage des anticorps anti-TPO
- C- Un aspect d'une « Thyroïd Inferno » à l'échographie est en faveur d'un goitre multi-nodulaire toxique
- D- La présence d'un nodule à l'échographie nécessite la réalisation systématique d'une scintigraphie thyroïdienne
- E- Un nodule chaud toxique se manifeste à la scintigraphie à l'iode 123 par une hyperfixation localisée avec extinction du reste du parenchyme

40- Parmi les étiologies des hypothyroïdies périphériques on distingue :

- A- Les pan-hypopituitarismes
- B- Les thyroïdites auto-immunes
- C- La carence iodée
- D- La maladie de Basedow
- E- Les goitres multinodulaires toxiques

41- Les macronutriments :

- A- Sont les seules sources d'énergie pour le corps humain
- B- Sont au nombre de 13
- C- Comprennent les vitamines liposolubles et hydrosolubles
- D- Ne comprennent que les oligo-éléments
- E- Comprennent les glucides, les protéines et les lipides

42- Concernant les glucides :

- A- Un index glycémique d'un aliment à 80 % est considéré comme un index glycémique élevé
- B- L'index glycémique d'un aliment peut varier chez la même personne en fonction de la teneur du repas en fibres, en glucides, en lipides et en protéines
- C- La charge glycémique est plus pertinente que l'index glycémique
- D- Les glucides contenus dans le miel ont un index glycémique plus bas que celui des glucides contenus dans les légumineuses
- E- Dans l'industrie alimentaire, le terme « sucre » correspond au saccharose

43- L'effet incrétine :

- A- Est impliqué dans la physiopathologie du diabète de type 1
- B- Concerne deux principaux peptides : lipase et amylase
- C- Explique la différence de sécrétion de l'insuline après l'administration orale ou intraveineuse du glucose
- D- Explique la survenue des hypoglycémies sévères chez le diabétique
- E- Concerne deux principaux peptides : GLP1 et GIP

44- L'insulinorésistance:

- A- Est le mécanisme physiopathologique prédominant dans le diabète de type 1
- B- Peut être responsable d'un hyperinsulinisme
- C- Se manifeste au niveau hépatique par l'inhibition de la néoglucogénèse
- D- Est secondaire à l'obésité gynéoïde
- E- Peut être responsable au long cours d'une apoptose des cellules Bêta pancréatiques

45- Parmi les propositions suivantes concernant l'hémoglobine glycosylée (HbA1C), cochez les propositions justes :

- A- Est basée sur le principe de glycation des protéines et de l'hémoglobine
- B- Est un rapport exprimé en microgramme par décilitre (ug/dl)
- C- Reflète la moyenne des glycémies sur les 3 derniers mois
- D- La réduction d'un point de l'HbA1C réduit de 16% le risque d'infarctus du myocarde chez le diabétique
- E- Doit être mesurée toutes les semaines dans le cadre de l'autosurveillance chez le diabétique

46- Le diabète de type 1 :

- A- Est associé à une réduction de l'effet incrétine
- B- Est dû à une atteinte autoimmune du pancréas exocrine
- C- Est plus fréquent que le diabète de type 2
- D- Est associée à une insulino carence
- E- Est traité par l'insuline

47- Le tableau clinique dans le diabète de type 1 :

- A- Est progressif et silencieux
- B- Se caractérise une importante prise de poids
- C- Est révélé par une hypoglycémie initiale
- D- Est souvent déclaré sur un mode aigu
- E- Est révélé par une acidocétose

48- Cochez les étiologies de diabètes secondaires :

- A- Les pancréatites
- B- Une maladie d'Addison
- C- Le phéochromocytome
- D- Un adénome corticotrope
- E- La maladie de Cushing

49- Une patiente de 53 ans, enseignante de profession, non connue diabétique avec antécédent de diabète gestationnel lors de sa dernière grossesse il y'a 4 ans, admise au service de cardiologie pour trouble du rythme cardiaque. Le bilan biologique à l'admission révèle une glycémie à 2,85 g/l. Cette hyperglycémie peut être en rapport avec :

- A- Un diabète de type 1
- B- Un diabète insipide
- C- Un diabète de type 2
- D- Un diabète iatrogène
- E- Une hyperglycémie de stress

50- Le bilan réalisé le lendemain a montré chez cette patiente, une glycémie à jeun à 1,34 g/l et une HbA1C à 8,6% sans aucune administration d'insuline correctrice. De quel type de dysglycémie s'agit-il ?

- A- Un état prédiabétique
- B- Un diabète de type 2
- C- Une intolérance au glucose
- D- Un diabète de type 1
- E- Une hyperglycémie modérée à jeun



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

Code candidat

Nom

Prénom

Remarques :

Université Cadi Ayyad
FMM Marrakech
Année Universitaire 2025-2026
Session Janvier 2026
Glandes Endocrines et Revet
Cutanés
4ème Année Médecine

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☐	☒	☐
Q2	☒	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☒	☐	☒
Q4	☐	☐	☒	☐	☐
Q5	☐	☒	☐	☒	☐
Q6	☐	☐	☐	☒	☐
Q7	☐	☒	☒	☒	☐
Q8	☐	☐	☒	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☒	☐
Q10	☐	☐	☒	☐	☐
Q11	☐	☐	☒	☐	☐
Q12	☐	☒	☒	☐	☒
Q13	☒	☐	☒	☐	☒
Q14	☒	☒	☐	☒	☐
Q15	☒	☒	☒	☐	☐
Q16	☒	☐	☒	☐	☒
Q17	☒	☒	☒	☐	☐
Q18	☒	☐	☐	☒	☐
Q19	☐	☐	☐	☒	☐
Q20	☐	☒	☐	☐	☐
Q21	☐	☒	☐	☐	☐
Q22	☒	☐	☐	☐	☐
Q23	☒	☒	☒	☒	☐
Q24	☒	☐	☐	☐	☐
Q25	☒	☐	☒	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q26	☐	☒	☐	☐	☒
Q27	☒	☐	☐	☐	☒
Q28	☐	☒	☒	☐	☒
Q29	☒	☐	☐	☐	☐
Q30	☒	☒	☐	☐	☒
Q31	☒	☐	☒	☒	☐
Q32	☒	☐	☐	☒	☐
Q33	☐	☒	☐	☐	☐
Q34	☒	☐	☐	☐	☐
Q35	☒	☐	☐	☒	☐
Q36	☒	☐	☐	☒	☐
Q37	☒	☐	☐	☐	☐
Q38	☐	☐	☐	☒	☐
Q39	☒	☐	☐	☒	☒
Q40	☐	☒	☒	☐	☐
Q41	☒	☐	☐	☐	☒
Q42	☒	☒	☒	☐	☒
Q43	☐	☐	☒	☐	☒
Q44	☐	☒	☐	☐	☒
Q45	☒	☐	☒	☒	☐
Q46	☐	☐	☐	☒	☒
Q47	☐	☐	☐	☒	☒
Q48	☒	☐	☒	☒	☒
Q49	☐	☐	☒	☐	☒
Q50	☐	☒	☐	☐	☐

AE → ABLE

BDE → DE